



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

SOUS LE HAUT PARRAINAGE DE
**PROFESSEUR
HOUNKPATIN BENJAMIN**
MINISTRE DE LA SANTÉ BENIN

SOUS LA PRÉSIDENTIE D'HONNEUR DE
**PROFESSEUR MARINA
D'ALMEIDA MASSOUGBODJI**
PROFESSEUR TITULAIRE DE CARDIOLOGIE



4ème CONCRÈS INTERNATIONAL DE LA SBC & 3ème
CONCRÈS INTERNATIONAL DE L'ASCAOC

LIVRE DES RESUMES



**La cardiologie africaine à l'épreuve d'un
double fardeau :** flambée des maladies
non transmissibles et impact des maladies
transmissibles

souvent, les personnes présentant une obésité sont en souffrance psychique, caractérisée par une diminution de l'estime de soi, une insatisfaction globale de la vie, de l'impulsivité, des sentiments de frustration et de culpabilité, et des difficultés relationnelles. Il n'est pas rare que l'obésité soit associée à la présence de troubles psychiques comme la dépression et l'anxiété.

Conclusion : Devant une obésité, il est primordial de rechercher les facteurs psychosociaux qui peuvent être à l'origine ou entraver la réduction de poids.

Mots clés : obésité, perception psychosociale, prise en charge

CF23. Prise en charge nutritionnelle de l'obésité

Conférencier : C. S. AZANDJEME^{1,2}

¹Service de Nutrition du Centre Hospitalier Universitaire-Mère Enfant Lagune, ²Institut Régional de Santé Publique, Université d'Abomey-Calavi, Route des esclaves, BP 188, Cotonou



Introduction: L'obésité est un réel problème de santé publique aussi sérieux que la malnutrition et les maladies infectieuses. Elle est actuellement considérée comme une maladie chronique, évolutive souvent associée à une invalidité et à la menace de complications graves. La présente conférence vise à clarifier les objectifs et le processus de prise en charge (PEC) nutritionnelle de l'obésité.

Contenu: L'obésité et la surcharge pondérale constituent un facteur de risque de plusieurs maladies non transmissibles dont les maladies cardiovasculaires, le diabète et les cancers.

Son ampleur est croissante dans un contexte de transition nutritionnelle et de pauvreté et de limitation d'accès aux ressources, tous favorables à son expansion. Les facteurs de risque sont biologiques, comportementaux, socio-culturels, environnementaux, et ceux liés au système de santé et de gouvernance.

La PEC nutritionnelle passe par une éducation structurée, adaptée à la personne, selon ses préférences et aversions, visant la réduction des apports tout en maintenant l'équilibre et la diversité alimentaires. Au-delà de la réduction du poids corporel, elle vise la régulation du métabolisme glucidique et lipidique.

L'accroissement de la dépense énergétique et la modulation du mode de vie, incluant la gestion du sommeil, la gestion psychologique du stress et des émotions, la promotion d'environnements sains, et la pratique d'exercices physiques, tout en déconstruisant le construit socio-culturel de l'image corporel en faveur de la surcharge pondérale, constituent les aspects non négligeables de la prise en charge de la personne obèse qui sont gages du retour à un état nutritionnel qui favorise la bonne santé.

Conclusion : La prise en charge nutritionnelle bien qu'essentielle dans la PEC globale de l'obésité, doit s'inscrire dans un cadre de co-construction, de collaboration multisectorielle. Des programmes de promotion de la santé, de prévention et de prise en charge holistique permettront de mieux contrôler ce phénomène.

Mots clés : Obésité, Prise en charge nutritionnelle, Promotion de la santé, Prévention, Multisectorialité.